世界卫生组织

©

抑郁障碍（抑郁症）

2025年8月29日

English | العربية | Français | Русский | Español

重要事实

- **抑郁症是一种常见的精神障碍。**
- **据估计，全球有5.7%的成年人患有抑郁症。**
- **受抑郁症影响的女性比男性更多。**
- **抑郁症可导致自杀。**
- **已有对轻度、中度和重度抑郁症行之有效的治疗方法。**

概述

抑郁障碍（也称抑郁症）是一种常见的精神障碍，涉及长时间情绪低落或失去快乐或对活动的兴趣。

抑郁症不同于正常的情绪变化和对日常生活的感觉。抑郁症可以影响生活的方方面面，包括与家人、朋友和社区的关系。抑郁症可能是由学校和工作中的问题引起的，也可能引起学校和工作中的问题。

抑郁症有可能发生在任何人身上。经历过虐待、重大损失或其他压力事件的人更容易患上抑郁症。女性比男性更容易患抑郁症。

估计有4.0%的人口患有抑郁症，其中包括5.7%的成年人（男性为4.6%，女性为6.9%），以及5.9%的70岁（含）以上的成年人。世界上大约有3.32亿人患有抑郁症*(1)*。抑郁症在女性中的发病率是男性的1.5倍左右。在世界范围内，超过10%的孕妇和刚分娩的妇女患有抑郁症*(2)*。2021年，估计有72.7万人因自杀丧命。自杀是15-29岁人群的第三大死因*(1)*。

在高收入国家，只有大约三分之一的抑郁症患者接受精神卫生治疗*(3)*。

有效治疗的障碍包括：缺乏对精神卫生保健的投资，缺乏训练有素的卫生保健提供者，以及社会对精神疾患的歧视等。

症状和类型

在抑郁发作期间，一个人会经历抑郁情绪（感到悲伤、烦躁、空虚）。他们可能会感到失去乐趣或对活动的兴趣。

抑郁发作不同于正常的情绪波动。抑郁情绪几乎每天都会发作，在一天中的大部分时间持续，至少持续两周。

还存在其他症状，其中可能包括：

- **注意力不集中**
- **过度内疚或自我价值感低下**
- **对未来感到绝望**
- **有死亡或自杀的想法**
- **睡眠紊乱**
- **食欲或体重变化**
- **感觉非常疲倦或精力不足。**

抑郁症会在生活的各个方面造成困难，包括社区和家庭、工作和学校。

抑郁发作可分为轻度、中度或重度，具体取决于症状多寡及严重程度，以及对个人功能的影响。

抑郁发作有不同的类型，包括：

- **单次发作的抑郁障碍，意指病人第一次也是唯一一次发作；**
- **复发性抑郁障碍，这意味着病人有至少两次抑郁发作史；以及**
- **双相情感障碍，意味着抑郁发作与躁狂症状交替出现，包括情绪高涨或易怒、活动增加或精力旺盛，以及其他症状，如健谈、思绪奔涌、自尊心增强、睡眠需求减少、分心和冲动鲁莽行为。**

成因和预防

抑郁症是社会、心理和生物因素综合作用的结果。在生活中经历过不良事件（失业、丧亲、创伤事件）的人更容易患抑郁症。抑郁症反过来可以导致更大的压力和功能障碍，影响患者的生活并加剧抑郁症状。

抑郁症与身体健康密切相关，并受其影响。影响抑郁症的许多因素（如缺乏身体活动或有害使用酒精）也是心血管疾病、癌症、糖尿病和呼吸系统疾病等疾病的已知危险因素。反过来，患有这些疾病的人也可能发现自己由于与管理病情相关的困难而经历抑郁症。

预防规划已被证明可以减少抑郁症。社区可为预防抑郁症采取有效措施，包括在学校开展规划以增强儿童和青少年积极应对的方式。针对有行为问题儿童的父母采取干预措施可以减轻父母的抑郁症状，并改善其子女的疾病结局。开展老年人体育运动规划也可有效预防抑郁症。

诊断和治疗

抑郁症已有有效治疗方法，包括心理治疗和药物。如果你有抑郁症的症状，请就医。

心理治疗是抑郁症的首选治疗方法。心理治疗可以与中度和重度抑郁症的抗抑郁药物联合使用。轻度抑郁症不需要抗抑郁药物。

心理治疗可以教授新的思维方式、应对方式或与他人相处的方式。心理治疗可能包括与专业人士和受监督的非专业治疗师的谈话疗法。谈话疗法可以当面进行，也可以在线进行。可以通过自助手册、网站和应用程序获得心理治疗。

抑郁症的有效心理治疗包括：

- **行为激活**
- **认知行为疗法**
- **人际心理治疗**
- **解决问题疗法。**

抗抑郁药物包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI），如氟西汀。

卫生保健提供者应该牢记与抗抑郁药物有关的可能副作用、提供干预措施的能力(就专业知识和/或治疗可及性而言)以及个人偏好。

抗抑郁药物不应用来治疗儿童抑郁症，也不应是青少年的一线治疗手段。对青少年应慎用抗抑郁药。

双相情感障碍有不同的药物和治疗方法。

自我保健

自我保健可以在管理抑郁症症状和促进整体健康方面发挥重要作用。

你能做的事：

- **尝试继续从事你曾经喜欢的活动**
- **与朋友和家人保持联系**
- **定期锻炼，即使只是散散步**
- **尽可能坚持规律的饮食和睡眠习惯**
- **避免或减少饮酒，不要使用非法药物，这可能会使抑郁症恶化**
- **与你信任的人谈谈你的感受**
- **向卫生保健提供者寻求帮助。**

如果你有自杀念头：

- **请记住，你并不孤单，许多人都经历过你正在经历的事情并找到了帮助**
- **与你信任的人谈谈你的感受**
- **与卫生工作者交谈，例如医生或咨询师**
- **加入支持小组。**

如果你认为你有伤害自己的直接危险，请联系任何可用的紧急服务或危机热线。

世卫组织的应对

世卫组织《2013-2030年精神卫生综合行动计划》强调了为包括抑郁症在内的精神障碍患者提供适当干预所需的措施。

抑郁症和自残/自杀是世卫组织精神卫生差距行动规划 (mhGAP)所涵盖的一个重点疾患。该规划的目标是，帮助各国通过并非精神卫生专家的卫生工作者提供的照护，增加对精神、神经和物质滥用患者的服务。

世卫组织编写了抑郁症心理干预简明手册，可由非专业治疗师向个人和群体提供。其中一个例子就是《问题管理+手册》，描述行为激活、压力管理、解决问题的治疗和加强社会支持等手段。此外，《抑郁症群体人际关系疗法手册》描写的是抑郁症的群体治疗。最后，《思维健康手册》包括使用认知行为疗法治疗围产期抑郁症。

参考文献

(1) 2021 年全球疾病负担 [在线数据库]。西雅图：卫生计量和评估研究所；2024年（https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/，2025年8月13日访问）。

(2) Woody CA、Ferrari AJ、Siskind DJ、Whiteford HA、Harris MG。围产期抑郁症患病率和发病率的系统评价和元回归分析。《情感障碍杂志》。2017年；219:86–92。

(3) Evans-Lacko S、Aguilar-Gaxiola S、Al-Hamzawi A 等。焦虑、心境障碍和物质使用障碍患者精神卫生治疗差距的社会经济差异：来自世界卫生组织世界精神卫生（WMH）调查的结果。《心理医学》。2018年；48(9):1560-1571。